

Plan na piśmie *konkretne cele i kryteria*

Bez strukturalnego planu trudno ocenić postęp. Klient odchodzi po 18 miesiącach z „nie wiem, czy to działa”. Plan = wspólna mapa, do której można wrócić.

CZAS: 15 min planowania z terapeutą **REALIZACJA:** pierwsze tygodnie terapii + okresowy przegląd

ŹRÓDŁO: Herman (1992, *Trauma and Recovery*); ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*); Bowlby (1988, bezpieczna baza); Cloitre i in. (2010, STAIR); Linehan (1993, umiejętności DBT)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy fazy z konkretnymi celami** (nie ogólnikami) i mierzalnymi kryteriami przejścia. W sekcji 02 — **oscylacje**: fazy nie są liniowe, pacjent może między nimi krążyć. Sekcja 03 — **twoje cele i metryki** dla obecnej fazy. Sekcja 04 — moja umowa z sobą i terapeutą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*) rekomenduje trójfazowy plan jako **międzynarodowy standard** opieki w C-PTSD. Bez planu na piśmie terapia często stagnuje — terapeuta i klient nie mają wspólnej mapy, trudno ocenić postęp, frustracja rośnie po obu stronach. Plan jest *narzędziem klinicznym*, nie biurokracją. **Faza 1 — STABILIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO.** Cele: (a) bezpieczeństwo fizyczne (jeśli przemoc trwa — najpierw interwencja kryzysowa, schronienie); (b) relacja terapeutyczna jako bezpieczna baza (Bowlby, 1988); (c) psychoedukacja normalizująca objawy; (d) umiejętności regulacji emocji (STAIR — Cloitre; umiejętności DBT — Linehan; *grounding*, oddech, okno tolerancji); (e) stabilizacja podstawowa (sen, jedzenie, rutyna, redukcja używek); (f) farmakoterapia, jeśli wskazana. Metryki: brak aktywnego ryzyka suicydalnego, okno tolerancji co najmniej 30 min, silny alians, ≥ 3 sprawdzone strategie *grounding*. Czas: 6–24 miesiące. **Faza 2 — PRZETWARZANIE TRAUMY.** Tylko gdy Faza 1 jest *solidna*. Metody: *prolonged exposure* adaptowana, terapia poznawczego przetwarzania, EMDR z modyfikacjami, STAIR + NST (Cloitre i in., 2012, RCT), *imagery rescripting* (Arntz), IFS (Schwartz). Wolniejsze tempo niż w prostym PTSD, monitorowanie okna tolerancji, przerwy na restabilizację. **Faza 3 — INTEGRACJA I REKONEKTYWNOŚĆ.** Odbudowa tożsamości („kim jestem poza traumą?”), relacji, sensu życia, wartości, celów. Wzrost potraumatyczny (ang. *posttraumatic growth*). Herman (1992): „*reconnection with ordinary life*”. **Ważne:** fazy nie są liniowe — pacjent może oscylować. Wielu pacjentów potrzebuje *głównie* Fazy 1 — stabilizacja jest wartościowym celem terapeutycznym samym w sobie.

01 Trzy fazy — cele i kryteria przejścia

FAZA 1 · 6–24 MIES.

Stabilizacja

Cele: bezpieczeństwo, alians, regulacja, sen/jedzenie/rutyna.

Metryki przejścia: brak aktywnego ryzyka, okno tolerancji ≥ 30 min, ≥ 3 strategie *grounding*, silny alians, zgoda pacjenta.

FAZA 2 · 12+ MIES.

Przetwarzanie

Cele: przetwarzanie wybranych wspomnień, redukcja intruzji i unikania, modyfikacja schematów.

Metryki: spadek intruzji, integracja narracji, brak destabilizacji po sesjach.

FAZA 3 · MIESIĄCE–LATA

Integracja

Cele: tożsamość, relacje, sens, wartości, plany długoterminowe.

Metryki: spójna narracja, satysfakcjonujące relacje, wartości jako kompas, wzrost potraumatyczny.

02 ? Fazy nie są liniowe — oscylacje są normalne

Pacjent w Fazie 2 może doświadczyć *destabilizacji* (życiowy kryzys, wyzwalczy, intensywniejsza praca z traumą) i wymagać **powrotu do Fazy 1** na kilka tygodni lub miesięcy. To *nie* regresja ani porażka — to **elastyczne dostosowanie tempa**, fundamentalna zasada pracy z C-PTSD.

Niektórzy pacjenci pozostają *głównie w Fazie 1* przez całą terapię — i to też jest sukces. Stabilizacja sama w sobie zmienia jakość życia: lepszy sen, mniejsza dysregulacja, bezpieczne relacje, mniej kryzysów. Nie każdy pacjent *musi* przejść do bezpośredniego przetwarzania traumy, by terapia była wartościowa.

03 ✎ Moje cele dla obecnej fazy

MOJA OBECNA FAZA

— hipoteza: Faza 1 / na pograniczu 1–2 / Faza 2 / Faza 3;
dlaczego tak sądzę

MOJE 3 CELE DLA OBECNEJ FAZY

— konkretne, mierzalne, do uzgodnienia z terapeutą

MOJE METRYKI POSTĘPU

— po czym poznam, że posuwam się do przodu (np. dni z dobrym snem, długość okna tolerancji, liczba kryzysów)

CO MOGŁOBY MNIE DESTABILIZOWAĆ

— wyzwalcze, sytuacje życiowe, momenty wymagające powrotu do strategii Fazy 1

Klucz: plan na piśmie z konkretnymi celami i metrykami jest *narzędziem klinicznym*, nie biurokracją. Bez niego po 18 miesiącach klient mówi „*nie wiem, czy to działa*” — i odchodzi. Z nim — można wrócić do umowy: „*oto co planowaliśmy w Fazie 1, oto co osiągnęliśmy, oto co dalej*”. Plan to *nie* obietnica, że wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem — to wspólna mapa, do której można wrócić, gdy terapia się gubi. ISTSS (2019) rekomenduje plan w pierwszych 4–6 sesjach, z okresowym przeglądem co 3–6 miesięcy. Jeśli twoja obecna terapia nie ma takiego planu — poproś o niego.

△ Plan ma być żywy, nie sztywny. Cele można modyfikować w miarę pracy — to znak elastyczności, nie porażki. „Cele rok temu” mogą wyglądać dziś inaczej, bo zmieniła się sytuacja życiowa, pojawiły nowe odkrycia, pacjent dorósł do innego rozumienia siebie. Przegląd planu = ważna sesja, nie strata czasu.